

Bouchentouf 1

Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Donc, on va commencer des cas cliniques. J'ai préparé trois cas cliniques. Et au fur et à mesure, on va essayer de les résoudre.

Après faire une synthèse. Et de là va sortir les questions que vous posez dans l'examen. J'espère que ça passera dans de bonnes conditions.

Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Donc, on peut commencer maintenant par le premier cas clinique. Donc, vous avez un jeune patient de 22 ans, de bas niveau socio-économique, qui est non tabagique, et qui présente une douleur basi-thoracique droite, avec une toux sèche et des signes généraux.

Les signes généraux, c'est la fièvre, la cyanoxure, l'altération par général. Dans l'examen clinique, on a trouvé à droite une matité, une abolition des vibrations vocales à droite, une abolition des murmures vicaux à droite, et le reste de l'examen clinique, c'est-à-dire les agréments cardio-vasculaires, les agréments pulmonaires, les autres appareils, était normal. Donc, on va passer à la première question.

Quel est le diagnostic que vous évoquez en premier ? Est-ce que vous évoquez une pneumopathie droite, un pneumothorax droit ou une pleurisy droite ? Dans quel diagnostic vous évoquez ? Est-ce que vous pouvez répondre ? Est-ce que c'est une pneumopathie droite, un syndrome d'épanchement liquidien droit, un pneumothorax, c'est-à-dire un syndrome d'épanchement aérien droit, ou une pleurisy droite ? Une pleurisy droite. Une pleurisy droite. Donc, une pleurisy droite, et c'est basé sur des signes cliniques qui sont la douleur, qui est déclenchée ou aggravée par le changement de position, par la toux sèche.

Et dans l'examen clinique, vous allez trouver un syndrome d'épanchement liquidien. Pleural liquidien. Ça se traduit par une matité, une diminution des murmures vicaux, et une diminution des vibrations vocales.

C'est un syndrome d'épanchement liquidien. Dans les signes cliniques, quels sont les éléments sur lesquels vous devez insister ? Les signes cliniques que vous devez insister. Vous avez la toux.

Est-ce que dans la pleurisy, la toux, elle est comment ? Est-ce qu'elle est sèche ou productive ? Dans le syndrome d'épanchement liquidien, la toux, elle est comment ? Est-ce qu'elle est sèche ou productive ? Sèche ou productive ? La toux, est-ce qu'elle est sèche ou productive ? Est-ce que vous m'entendez ? Dans le syndrome d'épanchement liquidien, est-ce que la toux, elle est sèche ou productive ? Est-ce qu'elle peut être productive ? Est-ce qu'elle peut être productive ? La toux est sèche. Parce que s'il y a une fistule broncho-pleurale, ça peut être productive lorsqu'il y a une brèche ou une fistule entre la cavité pleurale et les bronches. Normalement, notre malade a une toux sèche.

Il n'a pas cette fistule, il a la toux sèche. Une douleur thoracique avec des signes génériques. Néros et l'examen clinique.

Donc, quel bilan vous allez demander ? Quel bilan vous allez demander en première intention ? Quel bilan vous allez demander ? C'est très évident, devant une symptomatologie respiratoire, une radiographie thoracique de face. Bravo, une radiographie thoracique de face. Ma question, est-ce que c'est un examen qui confirme le diagnostic ou oriente le diagnostic ? La radiographie thoracique, est-ce que c'est un examen qui confirme le diagnostic ou oriente vers le diagnostic ? Confirmer, c'est-à-dire le diagnostic de certitude.

Est-ce que la radiographie thoracique confirme le diagnostic ? C'est-à-dire, il fait un diagnostic. Il oriente le diagnostic. Donc, il oriente le diagnostic.

Donc, vous allez faire une radio. Donc, on va voir la radiographie de notre patient. La radiographie de notre patient, la voilà.

La voilà. Ce n'est pas l'échographie qui confirme le diagnostic. L'imagerie, en général, c'est un élément d'orientation.

Là, M. Hejlewski, l'examen radiologique, ce sont des éléments d'orientation. Ce ne sont pas des éléments qui confirment le diagnostic. Donc, on ne va pas passer.

Il ne faut pas passer. Il ne faut pas précipiter les choses. Restons à la radio.

Est-ce que vous pouvez interpréter cette radio ? Je vous ai mis la flèche. Je vous mets la flèche. Est-ce que vous pouvez décrire cette image ? Est-ce que vous pouvez décrire l'image ? En radiologie, c'est très évident.

Ce qui est en noir, c'est une clarté. Ce qui est en blanc, c'est une opacité. Donc, c'est une opacité.

Il est où cette opacité ? Il est basi-toracique. Quels sont les critères qui orientent vers... C'est une opacité tonalité hédérique. Bravo, bravo, Idrissa.

C'est une opacité de tonalité hédérique. Oui, continuez. D'autres éléments à ajouter.

Concave en rond et en dedans. Qui efface la coupole diaphragmatique. Et complique le sac.

Donc, l'opacité de type plurale. C'est une opacité de tonalité hédérique basi-toracique. Concave en rond et en dedans.

Qui efface la coupole diaphragmatique. Et complique le sac. Donc, c'est une opacité.

Cliniquement, c'est un syndrome d'épanchement plurale. Radiologiquement, c'est un syndrome d'épanchement plurale. Mais, quel est l'examen qui va confirmer le diagnostic ? Quel est

l'examen qui va confirmer le diagnostic ? L'examen qui va confirmer le diagnostic d'un syndrome d'épanchement plurale.

Liquidien. C'est la ponction. Il faut compléter la réponse.

Et mieux, ponction plurale exploratrice. La ponction plurale exploratrice. Parce qu'il y a la ponction biopsy plurale.

Et il y a la ponction évacuatrice. Il faut parler de l'examen pour compléter la question. Pour que votre réponse soit correcte de manière générale.

Une ponction plurale exploratrice. Donc, le diagnostic n'est pas de certitude. Ce n'est pas la radiologie.

Mais le diagnostic de certitude est donné par la ponction plurale exploratrice. Donc, techniquement, quelles sont les précautions que vous devez prendre avant de faire une ponction plurale ? Quelles sont les précautions que vous devez faire avant de faire une ponction plurale ? Et où vous allez ponctionner ? Ce sont des éléments très très importants. Les éléments et les précautions que vous allez faire avant de faire une ponction.

Bilan démontre. Bilan démontre. Bravo.

Carport TP, TCA et le taux de plaquette. Éliminer les contre-indications. Bravo Eric.

Ce sont les contre-indications. Les contre-indications d'une ponction plurale. C'est éliminer un.

Éliminer quoi ? Les contre-indications, c'est un problème de bilan de l'hémostase. Et surtout, ce n'est pas l'infection. C'est une complication.

L'infection incistidatique pulmonaire. Incistidatique pulmonaire. Il faut compléter la phrase, s'il vous plaît.

Je ne sais pas, on enregistre. Elle va être enregistrée. L'essentiel, le incistidatique pulmonaire.

Vous allez ponctionner où ? Vous allez ponctionner où ? A quel endroit ? Et pourquoi ? A quatre doigts en dedans des vertèbres d'os. Non, ce n'est pas ça. Il faut ponctionner en plein matité.

Les quatre doigts en dedans, en dedans, pour éviter les rapports osseux. Ça, c'est autre chose. Mais, une ponction se fait en plein matité.

C'est-à-dire, vous allez examiner votre malade. Vous avez une percussion, vous trouvez la matité. Et vous allez délimiter un espace intercostal.

Vous avez rasé le bord supérieur de la côte inférieure. Pourquoi ? Raser le bord supérieur. Le bord, ce n'est pas là.

La côte inférieure, mais le bord supérieur de la côte inférieure. Vous avez un espace. Vous avez la côte supérieure, la côte inférieure.

Dans la côte inférieure, son bord supérieur, vous le rasez. Pour éviter le paquet vasculaire. Bravo, Marwa.

Le paquet, c'est-à-dire, si vous ne panctionnez pas à ce niveau. Vous allez avoir des saignements. Et vous allez avoir de la douleur.

Le malade va se sentir mal. Et vous aurez des saignements. Donc, il faut se rappeler.

C'est l'espace intercostal. Le bord supérieur de la côte inférieure. Pour éviter le paquet vasculaire.

Vous allez faire une panction. Quel résultat vous attendez ? Quel résultat vous attendez ? Vous avez attendu. Vous allez retirer du liquide.

C'est bien pour confirmer des instructions. Mais quel résultat vous attendez ? Quel type de liquide vous pouvez retenir ? Le type de liquide que vous devez retenir. Donc, si vous faites une panction, vous reprenez du liquide.

Donc, c'est un pleurésie, un syndrome de panchement liquide. Mais moi, je veux aller plus loin. Quel type vous allez trouver ? Quel type que vous connaissez ? Quel type de panchement liquide ? Il y a plusieurs types de panchement liquide.

Sérofibrine. Séro-hématique. Citrin.

Ou séro-hématique. Liquide genre citrin. Oui.

Chil. Oui. Chil.

Chil avec Y. Chil avec Y. Chil qui vient du canal thoracique. Généralement, il y aura du liquide genre clair. Du liquide genre clair.

Du liquide genre citrin. Ou sérofibrine. Du liquide séro-hématique.

Du liquide hémorragique. Du liquide pyrulant. Il y a du liquide chileux.

Généralement, on aura un problème entre le liquide genre citrin ou genre clair. C'est quoi la question que vous posez lorsque vous avez un prélèvement comme ça ? Genre citrin ou genre clair ? C'est quoi la deuxième question que vous devez vous poser si vous trouvez du liquide genre citrin ou genre clair ? Est-ce que le liquide est de quel type ? Un transsudat et un exsudat. C'est ça la réponse.

Un transsudat ou un exsudat. Lorsque vous faites le sang à part, le liquide hémorragique, séro-

hématique, pyruvique, choleux, etc. Mais je parlerai généralement sur un liquide genre ascite.

Donc peut-être genre clair et genre citrin. La question, c'est de déterminer si c'est un transsudat ou un exsudat. Comment on va savoir si c'est un transsudat ou un exsudat ? Quel bilan on va demander ? Parce que vous devez savoir si c'est un transsudat ou un exsudat.

Bien sûr, on va se baser sur la biochimie. Le taux de protéines. Bravo, le taux de protéines.

Soit qu'il est bas, donc c'est un transsudat. Soit qu'il est élevé, c'est un exsudat. Est-ce que vous connaissez les valeurs ? Les valeurs pour dire un taux de protéines bas, c'est un transsudat ou un exsudat.

Le taux. Moins de 25, c'est un transsudat. Supérieur à 35, c'est un exsudat.

Mais si vous avez 30, vous le classez dans quelle catégorie ? Est-ce que c'est un transsudat ou un exsudat ? Qu'est-ce que vous allez faire pour régler le problème ? Entre 35 et 25, c'est-à-dire 30. Il faut savoir les critères de l'AIDS. Bravo.

C'est bien, le SELMA, c'est doser le LDH, l'actico-déshydrogénase. S'il est inférieur à 200, c'est un transsudat. S'il est supérieur à 200, c'est un exsudat.

Également, faire le rapport entre le taux de protéines pleurale divisé par le taux de protéines sanguines ou le LDH pleural sur les LDH sanguins. Pour les protéines, il doit être supérieur à 0,5. S'il est supérieur à 0,5, c'est un exsudat.

Ou le LDH sur le LDH pleural sur les LDH sanguins, supérieur à 0,6, c'est un exsudat. Nous avons fait un prélèvement. Nous n'avons pas dans ce chapitre 30 entre 25.

Nous avons un taux de protéines de 69 grammes par litre et un aspect macroscopique Jean Citrin. Vous concluez à quel résultat ? Vous avez l'aspect Jean Citrin, vous avez dosé vos protéines, vous trouvez 60 grammes. Donc, c'est quoi ? C'est un ? Votre liquide, il est quoi ? Un transsudat ou un exsudat ? C'est un transsudat.

C'est un exsudat, c'est évident. Il est supérieur à 30 grammes par litre. Donc, c'est un exsudat.

C'est très bien. A votre avis, quelles sont les étiologies probables ? Les étiologies probables, c'est ce que vous voulez. Mais on va choisir les plus probables.

Les étiologies d'une manière générale, puis on va voir sur notre patient. Tuberculose pleurale. Pour compléter la phrase, tuberculose pleurale.

Le résidu tuberculose. On parlera de tumeur, de pleurysie tumorale. Pleurysie tuberculose, pleurysie tumorale.

Quoi d'autre ? La couleur du liquide. La couleur du liquide, lorsque vous avez du liquide Jean

Clair et Jean Citrin. Citrin, c'est-à-dire, vous avez trouvé, c'est des dépôts de fibrine.

Donc, c'est un nuxuda. Jean Clair, il est très clair, comme l'eau de roche. C'est plutôt.

Pour qu'il y ait du purulent, c'est exudatif. Pour l'achilleuse également, pour l'autre, pour la séro-hématique. Mais nous, on va se focaliser sur la plus fréquente qu'on voit en consultation, en pratique pneumologique.

Les diagnostics que vous avez, ok, bien. Pleurysie tuberculose. Tumeur pleural ou métastase pleural ou pleurysie néoplasique.

Une collagenose, une maladie de système. Oui, un lipis, un poulet artéthématoïde ou une cause cardiovasculaire. C'est ça, les quatre questions, les étiologies, je crois, les plus probables.

Donc, on aura soit une pleurysie tumorale. Une pleurysie tuberculose. Une pleurysie d'origine cardiovasculaire.

Une maladie de système. Mais dans notre cadre, ce sera soit la question A ou la question B. Mais nous revenons à notre malade. Le malade, il avait 22 ans.

Il n'est pas tabagique. De bas niveau socio-économique. Donc, le diagnostic le plus probable, c'est quoi? Dans notre cas, de manière générale, les étiologies de la pleurysie sont les pleurysies tumorales, tuberculeuses, cardiovasculaire, maladie de système.

Mais dans notre cas, ce patient de 22 ans qui présente des troubles de symptomatologie respiratoire, une pleurysie droite. Donc, quel diagnostic? C'est une tuberculose pleurale. C'est une tuberculose pleurale.

Alors, vous êtes orienté par une tuberculose pleurale. Quel examen? Mais on ne limite pas la cause tumorale. Mais quel examen vous allez demander après? Vous avez demandé la chimie.

Vous avez demandé la chimie. Pour donner, est-ce que c'est un transsuda ou un exsuda? Donc, vous avez répondu à une question. Est-ce que c'est un exsuda? Parce que le taux de protéines dépasse 35 grammes.

Il est à pratiquement 70 grammes par litre. Donc, quel examen vous allez demander? Pour être orienté par une pleurysie tumorale ou par une pleurysie tuberculeuse? Vous demandez quoi? Après la chimie, on vous demande quoi? La recherche de BK, c'est-à-dire la bactérie. La bactérie.

La cytologie est à la recherche de quoi? La cytologie est à la recherche de quoi? La cytologie. Elle est à la recherche de cellules malignes. Donc, lorsque vous faites un prélèvement de liquide pleural, vous faites un bond pour la chimie, pour vous dire est-ce que c'est un transsuda ou un exsuda.

Un bond pour la bactériologie, c'est-à-dire rechercher des germes banaux, rechercher le BK. Et un bond pour la cytologie, c'est-à-dire l'anapathie, pour rechercher des cellules malignes. Donc, lorsque vous faites un prélèvement de ponction pleurale, vous avez trois tubes.

Trois tubes. Un tube pour la chimie, en dosant le taux de protéines, à défaut le taux de LDH. Puis on aura un bactériologique, à la recherche de germes banaux, soit l'examen direct de la culture.

Et un troisième pour rechercher des cellules malignes. Vous aurez trois tubes lorsque vous faites la ponction pleurale. Donc, nous avons vu notre prélèvement.

On a trouvé à la cytologie, il n'y avait pas de cellules malignes. Sur la bactérie, on n'avait pas trouvé de germes. Mais on a trouvé une cytologie à prédominance lymphocytaire.

Pour confirmer le diagnostic, quel examen vous allez réaliser maintenant ? Quel examen vous allez réaliser ? On n'a pas retenu le diagnostic de tumeur parce qu'on n'a pas trouvé de cellules malignes. On n'a pas trouvé d'une pleurysie infectieuse. On n'a pas trouvé de germes.

On n'a qu'une formule lymphocytaire. Pour confirmer le diagnostic, quel geste vous allez faire ? Vous avez fait un examen clinique. Vous avez fait la radio.

Vous avez fait la ponction pleurale. Et maintenant, quel examen vous allez demander pour le diagnostic étiologique ? Quel examen vous allez demander pour le diagnostic étiologique ? Recherche de gènes experts dans le BK. Coloration de Jim Nielsen.

Je vous dis qu'il y a absence de germes. Ces examens, on les a déjà faits. Les examens bactériologiques, on les a déjà faits, la coloration.

On a fait la ponction biopsy pleurale. La ponction biopsy pleurale. La ponction biopsy pleurale.

Ponction biopsy pleurale. Il y a deux techniques de faire la ponction biopsy pleurale. Quelles sont ces deux techniques ? Pour faire une ponction biopsy pleurale, quelles sont les techniques ? Il y a deux techniques.

Soit on fait une biopsy pleurale à l'aveugle. Donc on fait une biopsy pleurale, on ne sait pas où ponctionner. Et on fait une ponction biopsy pleurale guidée par la thoracoscopie.

La thoracoscopie. Dans le cas de biopsy pleurale tuberculose, parce que l'inflammation est diffuse, donc on peut faire la biopsy pleurale à l'aveugle. Pour s'inspecter une pathologie tumorale, où les lésions sont localisées, on fait une biopsy pleurale sous thoracoscopie.

Sous thoracoscopie. Lorsqu'on explore les branches, c'est une bronchoscopie. Lorsqu'on explore le médiastin, c'est une médiastinoscopie.

Et lorsqu'on explore la plèvre, c'est une thoracoscopie. Donc on va montrer la ponction biopsy

pleural, l'aiguille d'Abrams, on fait une assise locale, une courte incision, on va introduire l'Abrams, on va avoir issu du liquide, puis on va faire des biopsies, et on va évacuer le liquide sans oublier le contrôle clinique et radiologique. Donc on est devant soit une pathologie tumorale, soit une pathologie tuberculeuse la plus probable.

Dans la biopsy pleural, qu'est-ce qu'on doit attendre comme résultat ? Comme résultat ? Ce jeune patient, qui a 22 ans, quand vous évoquez une tuberculeuse, qu'est-ce que vous allez trouver dans la biopsy pleural ? Qu'est-ce que vous allez trouver dans la biopsy pleural ? C'est un sujet de 22 ans, le diagnostic le plus probable, parce qu'il n'a pas de facteur de risque en métabolisme, il aura probablement une tuberculeuse. Qu'est-ce que vous allez attendre dans la biopsy pleural ? Granulome. Oui, un granulome.

Comment est ce granulome ? Vous pouvez caractériser le granulome ? Comment vous pouvez caractériser ce granulome ? Il est comment ? Il est caractéristique de la tuberculeuse. Il est comment ce granulome ? Le granulome, il est comment ? C'est un granulome. Comment vous caractérisez ce granulome ? Il est hypothéluïdo, gigantocellulaire, avec nécrose caselleuse.

C'est un granulome. Épithéluïdo ? Oui, gigantocellulaire, avec nécrose caselleuse. Nous avons un jeune patient de 22 ans, de bas niveau psychologique, qui présente une pleurésie sérophibrineuse à liquide joncitrin exudatif, et dont la psychologie est lymphocytaire, et dont la biopsy pleural met en évidence un granulome épithéluïdo gigantocellulaire avec nécrose caselleuse.

Donc nous sommes devant une pleurésie tuberculeuse. Pleurésie tuberculeuse. Comment vous allez la traiter, la tuberculose pleurale ? Comment vous allez traiter la tuberculose pleurale ? Comment vous allez la traiter ? Comment vous allez traiter ce patient ? Tout d'abord, il y a un traitement médical.

Ce traitement médical, on l'appelle comment ? Le traitement médical ? Les antibacillaires. Bravo, les antibacillaires. Pour enregistrer ? Pour les antibacillaires, oui.

Quoi d'autre ? Il vous reste deux réponses. Les antibacillaires, on va parler, parce que ce n'est pas votre stade. On va vous donner une petite explication, oui.

Donc vous avez les antibacillaires. Quoi d'autre ? Il y a deux qui manquent. Les antibacillaires, c'est le traitement primordial.

Vous devez avoir les antibacillaires pendant deux à six mois. En plus des antibacillaires, vous devez avoir quoi comme traitement ? Vous avez le liquide. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce liquide ? Vous avez une ponction.

Ce n'est pas le drainage. On va parler du drainage après. C'est une ponction évacuatrice.

Donc on aura un traitement antibacillaire, une ponction évacuatrice, et le reste, un élément

important, c'est quoi ? La kinésithérapie respiratoire. Pour les ontalgiques, les onticicios, c'est un traitement symptomatique. Mais les bases du traitement, c'est un traitement antibacillaire, les ponctions évacuatrices et la kinésithérapie respiratoire.

Pourquoi la kinésithérapie respiratoire dans votre avis ? Pourquoi la kinésithérapie respiratoire est très importante dans le cas des rapprochements pleurs ? Il faut insister sur la kinésithérapie respiratoire. Pourquoi ? Pour ne pas être guéri avec des séquelles. Le drainage, c'est avec un drap.

La ponction, avec une aiguille. Éviter les séquelles. Éviter le développement de pas qui pleurent.

Très bien, très bien. Le traitement précoce, l'évacuation du ponchement et la kinésithérapie respiratoire, tous ces éléments, tous les trois, lorsqu'on les prescrit, c'est pour guérir le malade et éviter le développement de pas qui pleurent. Voici la réponse.

Le traitement d'une pleurésie tuberculeuse, dans le cas de notre patient, c'est un traitement antibacillaire, une durée de 6 mois, de RHZE4-RH, une ponction pleurale évacuatrice et une kinésithérapie respiratoire. Une kinésithérapie respiratoire. Nous avons terminé dans la pleurésie sérophibreuse.

Est-ce que vous pouvez différencier entre une pleurésie et l'évacuation ? Oui, l'évacuation se fait au moment de la ponction, mais il ne faut pas évacuer plus que de 800 cc pour éviter les chocs évacuants. Parfois, si on n'a pas le diagnostic histologique, si on vide rapidement, on va ponctionner quoi après ? On ne va pas tout vider. On va évacuer, mais pas tout vider.

Parce qu'on aura besoin, si le prélèvement histologique n'est pas concluant, on tombe sur du tissu normal, donc on doit refaire la biopsie. Il faut avoir du liquide pour refaire la ponction. Est-ce qu'il y a une différence entre séro-hématique et hémorragique ? Et comment vous faites la différence entre séro-hématique et hémorragique ? Vous dites que vous avez du liquide rouge, rougeâtre.

Vous dites que c'est un séro-hématique et ça, c'est un hémorragique. Ce n'est pas la même chose. Faites quoi comme manœuvre ? Un test à la compresse.

On n'a pas de test à la compresse. Les prélèvements changent de couleur, peut-être. La réponse est tout à fait facile.

Il faut agiter votre tube. Si ça coagule, c'est hémorragique. Si ça ne coagule pas, c'est séro-hématique.

Vous faites un prélèvement. Vous avez le tube, vous avez le prélèvement. Vous l'agitez un peu comme ça.

Si ça coagule, c'est hémorragique. Si ça ne coagule pas, c'est séro-hématique. Sur le plan

principe, hémorragique est dû à une rupture vasculaire.

Alors que séro-hématique est dû à une augmentation de la perméabilité de la plèvre. C'est-à-dire le passage des globules rouges d'un espace vasculaire vers l'espace pleural. D'accord ? Il y a un coagulable, oui.

Si vous l'agitez, ça ne coagule pas. Si ça coagule, c'est hémorragique. Donc, il faut appeler le chirurgien thoracique.

Probablement, c'est une rupture vasculaire. Probablement, c'est traumatique. Donc, on va faire un récapitulatif du pleurisy.

Le pleurisy, c'est un syndrome d'épongement liquidien. C'est l'étiologie la plus fréquente et dominée par la tuberculose, par les pathologies myoplasiques et les pathologies cardiovasculaires. La première question qui se pose.

Différencier entre une pleurisy exudative et transudative. Par quoi vous différenciez entre une pleurisy transudative et exudative ? Par quoi ? Par quel examen ? En pleurisy, par le taux de protéines. Et à défaut, les critères de light, si le taux est entre 25 et 35.

Pourquoi, dans la pleurisy transudative, vous ne faites pas de biopsies pleurales ? Et dans la pleurisy exudative, vous faites une biopsie pleurale dans le cas d'orientation étiologique. Dans la pleurisy transudative, on ne fait pas de biopsies pleurales. Pourquoi ? Et dans la pleurisy exudative, on doit faire des biopsies pleurales pour orientation étiologique.

C'est très bien. Dans le cas de la pleurisy transudative, la plèvre est saine. Alors que dans la pleurisy exudative, la plèvre est malade.

Donc vous faites de la biopsie pleurale si vous avez une pleurisy exudative. Donc vous avez les pleurisy exudatives, les étiologies sans, la tuberculose, la cause myoplasique, tumoral, les collagenoses. Vous avez les cardiovasculaires.

Quelles sont les étiologies des pleurisy transudatives ? Les étiologies, c'est très facile de les retenir. Par trois organes. Les étiologies des pleurisy transudatifs.

Par trois organes. Si vous connaissez ces organes, vous trouvez les étiologies. L'insuffisance, le cœur, le foie et le rein.

C'est ça. Si on vous dit pleurisy transudatif, si on dit insuffisance cardiaque, c'est transudatif. Si on dit cirrhose du foie ou insuffisance hépatocellulaire, c'est transudatif.

Si on vous dit rein ou syndrome néphrotique, c'est transudatif. Oui. Donc c'est ça, les étiologies transudatives.

Donc si vous voulez caractériser une pleurisy transudative, c'est une pleurisy avec un taux de protides qui est inférieur à 25 g. Qui a... Que la pleurèse est normale, on ne doit pas faire une ponction pleurale. Et les étiologies sont cellulaires. L'insuffisance cardiaque, l'insuffisance hépatocellulaire ou l'atteinte rénale ou le cas du syndrome néphrotique.

C'est ça, les étiologies des pleurisies transudatives. Donc lorsqu'on vous donne... La question que je dois poser, chaque fois on vous pose l'examen, vous avez des réponses un peu floues parce que vous ne connaissez pas comment j'ai énoncé le... Je dis, est-ce que la ponction pleurale dans le cas de pleurisy, elle est systématique ? Est-ce qu'elle est systématique ? La ponction pleurale, est-ce qu'elle est systématique ? Oui. Oui, elle est systématique, la ponction pleurale.

On doit la faire pour avoir un diagnostic. Mais parfois on se dit, est-ce qu'elle est toujours systématique ? Est-ce qu'elle est toujours systématique ? Donc lorsque je pose la question, est-ce qu'elle est systématique, il faut cocher vrai. Si je vous dis toujours systématique, non.

Parce que le terme toujours, parce qu'il y a des situations où on ne fait pas la ponction. Si la cause est connue, si la ponction est de faible abondance. Mais on va, lorsqu'on vous dit systématique, vous devez cocher systématique.

Lorsqu'on vous donne toujours systématique, il ne faut pas la cocher, c'est une réponse fautive. Pour ne pas avoir ce lapsus dans les termes. Systématique, c'est-à-dire on doit la faire.

Toujours systématique, c'est-à-dire on doit toujours la faire. On ne doit pas toujours la faire, si on a une mythologie cardiaque, on ne doit pas la faire. On va traiter la cardiopathie et le panchement pleural va se résorber.

Donc, on va passer le cas clinique numéro 2. Normalement, lorsqu'on traite, on doit surveiller. Lorsqu'on fait une ponction également, on doit surveiller. Lorsqu'on fait une biopsie pleurale, on doit surveiller.

On doit avoir une radiographie de contrôle de face obligatoire. Le cas clinique numéro 2. Donc, vous avez quelqu'un de 66 ans, c'est un sujet âgé, qui est tabagique, qui est diabétique, qui présente une douleur thoracique droite, une toux, fièvre et frisson, fièvre et frisson. L'examen clinique également trouve un syndrome de panche moléculaire.

Donc, le premier examen à demander, c'est quoi ? C'est logique, le premier examen à vous demander, chez ce patient, une radiographie thoracique. C'est banal, il faut demander un cliché thoracique. C'est pratiquement la même image.

C'est une opacité de tonalité hyérique. Effacement de la coupole diaphragmatique. Concave en haut et en dedans.

Maintenant, on va partir au plurisme périllant. Parce qu'il y a de la fièvre, il y a des frissons, il y a

l'altération tangénale. Donc, on évoque une plurisme périllante.

Lorsque le cours de la plurisme périllante, on a parlé du stade. Il y a trois stades dans la plurisme périllante. Quel stade, à votre avis, est votre plurisme périllant ? Quel stade ? Il y a trois stades dans la plurisme périllante.

Trois stades dans la plurisme périllante. Dans la plurisme périllante, il y a un stade de diffusion, de collection et d'enquistement. Donc, c'est un stade de collection.

Votre stade est de collection. Le stade de collection. Vous avez le stade de collection.

Dans quel geste vous allez réaliser ? C'est normal, vous allez faire une branchion plurale pour confirmer le diagnostic. Donc, les résultats que vous avez attendus, c'est quoi ? Le résultat, vous avez le plurisme périllant. Vous avez le malade, vous faites une panction, vous ramenez le liquide périllant.

Les résultats, c'est quoi ? Est-ce que c'est un transsudant ? Est-ce que c'est un transsudant ou un oxydan lorsque vous avez le plurisme périllant ? Le cas de plurisme périllant, est-ce que c'est un transsudant ou un oxydan ? C'est un oxydan parce que la plève, elle est malade, elle est infectée. Elle est infectée. Le plurisme périllant, c'est un oxydan.

Donc, le taux de protéines va dépasser 35 grammes. Est-ce que... Quel examen ou quel souci vous allez avoir devant un plurisme périllant ? Vous devez chercher quoi devant un plurisme périllant ? C'est quoi votre souci devant un plurisme périllant ? Vous devez chercher quoi ? Vous avez fait un prélèvement chimique. Il reste quoi, le prélèvement ? Le germe.

Donc, c'est bravo. Le germe. Devant un plurisme périllant, il faut rechercher le germe.

Le germe d'une manière générale. On ne va pas assister souvent des gens au germe, mais on va chercher les germes. Mais par quels moyens on va chercher les germes ? Par quels moyens vous allez chercher les germes ? Bien sûr, vous allez faire le prélèvement du liquide pleural.

Vous avez l'examen direct. L'examen... On va reprendre que notre... Nous sommes au stade de collection. Le grand stade.

Donc, justement, en diffusant, donc, notre cas, il est au stade de collection. Donc, le message. Le message que vous devez apprendre, que tout épanchement pleural, fébrile, doit être ponctionné.

On ne va pas attendre. Tout épanchement pleural, fébrile, doit être ponctionné. C'est une urgence.

Les plurises périllantes, c'est une urgence thérapeutique, parce que le pronostic est simple, parce qu'on a un retard de traitement. Donc, tout épanchement pleural, fébrile, doit être ponctionné. Donc, on doit faire un bilan microbiologique.

Donc, on va rechercher l'examen du pus, le liquide pleural, chercher des parasites également, et chercher également du BK. Mais, est-ce que la fibroscopie a une place ? La fibroscopie bronchique, est-ce qu'elle a une place dans la plurisie périllante ? Est-ce qu'elle a une place ? Est-ce qu'elle a une place ? La fonction, la fibroscopie, pourquoi elle a cette place ? La bronchoscopie, on fait une bronchoscopie. Devant toute plurisie périllante, on doit faire une fibroscopie.

Pourquoi ? Tout d'abord, pour faire des prélèvements, si on trouve des prélèvements, des prélèvements par voie pleural, liquide pleural est négatif, on peut faire des prélèvements par voie bronchoscopique. Pourquoi on fait la fibroscopie ? Un abcès. L'abcès, ça peut se compliquer de plurisie périllante.

L'abcès pulmonaire peut se compliquer. Illuminer, rechercher une myoplasie, c'est pas éliminer. Rechercher une myoplasie, rechercher une tumeur, c'est pas éliminer.

C'est un terrain. Vous voyez votre malade, il est âgé, il est tabagique. Il est âgé, il est tabagique.

Donc devant toute supérotation chronique, qu'elle soit plurale ou bronchique, il faut rechercher une myoplasie. C'est pourquoi on fait la fibroscopie bronchique. Donc les germes les plus fréquents, ce sont les germes les plus possibles.

Les germes possibles. Les germes possibles que vous devez rencontrer, que vous trouvez. Tout d'abord, les germes pyrogènes, comme l'a dit votre ami, les germes pyrogènes.

Quels sont les germes pyrogènes que vous connaissez ? Les germes pyrogènes. Un type d'exemple, donnez-moi un exemple de type pyrogène. Par exemple, si vous faites un prélèvement, vous sentez une odeur.

Une odeur qui est fétide. Donc les germes Banos, Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, oui. Oui.

Quoi d'autre ? Si vous avez un état buccodentaire défectueux, c'est les anaerobies. Les anaerobies. Oui.

On a les germes gammes positives, gammes négatives, des germes aérobies et anaerobies. Ce sont les germes Banos. Mais il y a d'autres germes qui peuvent donner cette pleurésie.

D'autres comme la tuberculose. La tuberculose peut donner tous les types de penchements pleurants. Le sérophobrineux, le séro-hématique, le périllant et le chineux.

Donc, également, il ne faut pas oublier qu'il faut rechercher, dans le cas d'une pleurésie périllante, il faut chercher la tuberculose. Donc, en cas de pleurésie périllante, tout d'abord, il faut instaurer le traitement rapide. Il faut hospitaliser les malades, bien sûr.

Mais surtout, il faut chercher le germe par des méthodes directes, c'est-à-dire au niveau du liquide pleural. On recherche les germes Banos et le BK à l'examen de l'agriculture. Mais on peut chercher au niveau de la porte d'entrée.

Si vous avez des lésions cutanées, si vous avez des mauvais états buccodentaires, on va à la fibroscopie. On est réellement à l'examen cyto-bactérien, des expectorations. Et par le sang, parce que le malade présente des frissons.

Le malade avait des frissons. Si on revient à l'observation, fièvre et frissons. Fièvre et frissons, ça traduit quoi, la fièvre et frissons ? La fièvre et frissons.

En cas d'infection. Ça traduit une septicémie. C'est-à-dire les germes sont dans le sang.

C'est pour cela qu'on fait des hémocultures. On fait des hémocultures. Vous voyez ? Parce que le malade avait des fièvres et frissons.

Il sera le passage des germes dans le sang, qu'on appelle septicémie. Et ces hémocultures, il faut les répéter. Donc devant une pleurésie périllante, il faut identifier le germe.

Parce que le traitement doit être dépendant du germe. On doit traiter en fonction du germe. Et les prélèvements.

La fibroscopie permet de faire des prélèvements pour confirmer, pour identifier le germe. Également, rechercher une pathologie sous-jacente, notamment une néoplasie. Donc les germes que vous avez dit, les plus fréquents, c'est les germes piogènes.

Vous avez les germes anaérobiques, les staphylococques, les pseudomonas. Il y a également la tuberculose. Mais parfois, lorsqu'on fait une ponction pleurale et qu'on cherche le germe, on ne le trouve pas.

Ce qu'on appelle les pleurésies périllantes bactériennes. Pourquoi elles sont bactériennes ? Peut-être que le malade a déjà pris des antibiotiques. Ils sont décapités.

Soit c'est une pleurésie tuberculeuse, soit une pleurésie amibienne. Non, le liquide chilleux, c'est comme du lait. Le liquide chilleux, c'est comme du lait.

Chilleux. Le canal thoracique, il est atteint du canal thoracique. C'est comme du lait.

C'est un problème du cholestérol et du triglycérides. C'est rare, c'est exceptionnel. C'est souvent post-traumatique en cas compliquant et chirurgical.

Périllant, c'est du pus. Du pus. Macroscopiquement.

Où, parfois, on trouve des liquides, genre comme ça, genre citrin, mais on trouve à la cytologie des polynucléaires altérés. La psy, ou le pus, ce sont des polynucléaires altérés. Et vous savez

que la pleurysie périllante évolue par des stades.

Un stade de diffusion, un stade de collection, un stade d'encaissement. C'est un stade d'évolution. Si vous avez une pleurysie abactérienne, vous devez évoquer une tuberculose, vous évoquez une pleurysie amibienne et vous évoquez une pleurysie décapitée par une antibiotérapie préalable.

Comment vous allez traiter la pleurysie périllante ? Comme la pleurysie tuberculose, vous avez dit un traitement antibacillaire, vous avez dit évacuation de l'épanchement et vous avez dit kinésithérapeute respiratoire. D'accord ? Antibiotiques, évacuation, kinésithérapeute respiratoire. Donc on va répondre aux questions item par item.

Antibiotérapie. Quel type d'antibiotique, de thérapie, vous devez utiliser ? Est-ce que par voie orale ? Est-ce que par voie parentérale ? Est-ce qu'il y a un seul antibiotique ou une association d'antibiotiques ? Et la durée, comment ce sera la durée ? Il faut répondre à cette question de l'antibiotérapie. Bien sûr, il doit être précoce pour éviter les complications.

Donc c'est une antibiotérapie par voie. Au début, il est par voie, l'antibiotérapie, il est par voie. Le malade qui a une pluriorsité pluriorsipérante, parentérale, injectable, doit être hospitalisé.

Une pluriorsité pluriorsipérante, le traitement, le traitement doit être en milieu hospitalier. Il faut hospitaliser le malade. Il faut prendre des voies vénérées.

Il faut faire une antibiotérapie en association de deux antibiotiques et dont la durée est prolongée. C'est entre quatre à huit semaines. Donc c'est une antibiotérapie précoce, parentérale au début, qui va être empirique au début, puis adaptée en fonction du germe et ce qu'on dirait qui est un peu prolongé.

La deuxième étape, l'évacuation de l'épanchement. Comment vous allez évacuer l'épanchement ? L'évacuation de l'épanchement. Comment vous allez évacuer l'épanchement ? Soit par une aiguille, une épanchement pleural évacuatrice, soit par un drainage pleural, soit par la chirurgie.

Alors le drain, pourquoi le drain ? Pourquoi le drain ? Pourquoi le drain ? Il faut reprendre le drain en fonction du stade. Le drain, parce que vous êtes en stade de ? Le drain, parce que vous êtes en stade. On a parlé des stades.

On a parlé des stades. On est à ce niveau, à ce stade. Ça, est-ce qu'on a besoin de drain à ce niveau ? A ce niveau, stade de diffusion.

On n'a pas besoin de drain. On a besoin uniquement du traitement antibiotérapique. Mais au stade ici de collection.

Stade de collection, on aura soit le drain, soit la panction. Mais qui va nous dire, est-ce que c'est le drain ou la panction ? Un examen fluo-liquide pleural, c'est quoi ? C'est rarement qu'on le

demande. C'est rarement qu'on le demande.

Mais c'est sur ce critère qu'on se base. C'est le pH. Le pH.

Le pH. Lorsqu'il est inférieur à 7,20, c'est acide. C'est un drainage.

S'il est supérieur à 7,20, c'est une panction. Mais en général, au stade de collection, on fait le drain. Donc sur notre patient, on va faire un drain.

Le drain, est-ce qu'il est de petit calibre ou de gros calibre ? Il y a beaucoup de drains et de dimensions qui parlent de petit à grand calibre. Vous allez utiliser quel drain ? Vous allez utiliser quel drain ? Un petit drain de petit calibre ou un drain de gros calibre ? Vous allez utiliser un drain de petit calibre ou de grand calibre ? Un drain de petit calibre au-delà de grand calibre ? Il faut répondre. Moi, j'utilise un drain de grand calibre.

Et vous ? Grand calibre parce qu'il peut se cailloter. Il peut se cailloter, il va du grumeau et peut vous boucher. Le drain, c'est les deux petits calibres.

Nous allons faire un peu le traitement. Tout d'abord, pour la pleurésie tuberculose, on n'a pas fait d'hospitalisation. On peut faire le diagnostic et le traiter à domicile.

Mais dans le cas de pleurésie pérulente, c'est une hospitalisation. On a parlé des antibiotiques. L'association de deux antibiotiques ou plusieurs en fonction des données du germe et la durée qui est prolongée.

Un drainage thoracique et une quinzithérapeute respiratoire. Mais ça, c'est pour traiter la pleurésie. Pour éviter qu'elle récidive, vous devez éradiquer les foyers infectieux.

Pour cela, il faut faire un examen de la cavité buccale, des radiosinus, correction des tars. Quel tar est-il à notre patient ? Le tar qu'il a à notre patient. On revient à notre patient.

Notre patient, c'est quoi le tar qu'il a ? Il est diabétique et le tabagique, probablement, ça peut être un néo. Ça peut être un néo. Ça peut être un néo.

C'est le tabagique. Ça justifie la réalisation d'une fibroscopie branchée. Également, il est diabétique.

On doit équilibrer son diabète. Parfois, on aura besoin, il est sous anti-diabétique ouro. Parfois, on aura besoin de l'insuline thérapeutique, de traitement insuline.

Il ne faut pas oublier le traitement, la pleurésie périllante. C'est une urgence. Donc la pleurésie, c'est une urgence thérapeutique.

On doit la traiter. On doit identifier le germe. On ne va pas attendre d'identifier le germe pour traiter.

On va traiter rapidement. Et surtout, la pleurésie périllante survient sur un terrain. Il faut chercher le terrain.

Il faut essayer d'équilibrer le terrain qu'on a sur ce terrain. On va essayer de terminer par un troisième cas clinique. Troisième cas clinique, c'est... Le mettre sur l'insuline, c'est pour de l'équilibre.

Ce sont de l'équilibre. Donc on doit chercher la glycémie, les sucres, l'acétone. Est-ce qu'il est équilibré ou non? C'est variable.

Est-ce que l'infection justifie la mettre en évidence? Bien sûr, l'infection, quand on est infecté, le diabète va se déséquilibrer. Mais on ne va pas traiter. Il faut se baser sur la glycémie, le sucre, l'acétone.

C'est autre chose. On peut le garder, mais on peut le mettre sur l'insuline. L'essentiel, c'est d'équilibrer son diabète.

Vous avez l'infection, vous avez le diabète. Si le diabète est mal équilibré, ça favorise les infections. Et si les oeufs et l'infection sont maltraités, ça déséquilibre un diabète.

Donc il faut bien traiter votre infection, qui est la pleurésie périllante, et bien équilibrer votre diabète. Ça marche en parallèle. Il faut équilibrer votre diabète par d'autres traitements, par augmentation de doses, soit par insulinothérapie.

C'est en fonction du malade, en fonction des données de l'immunogramme. Également, traiter l'infection. On doit les deux, parce que c'est une relation qui est réciproque.

Si l'infection n'est pas équilibrée, le diabète va être déséquilibré. Si le diabète est déséquilibré, alors que vous avez l'infection, ce sera mal contrôlé. Donc il faut contrôler les deux pathologies.

L'infection et le terrain sur lequel il survient. Donc nous avons le troisième cas. C'est un patient de 55 ans, tabagique, alcoolique, présentant une toux avec expectoration mycopéculente.

Toux avec expectoration mycopéculente, un syndrome fibrille, frisson et incarceration tagueynera. Et l'examen physique trouve un syndrome cavitare. C'est-à-dire un syndrome cavitare, vous avez un syndrome de condensation surmontée par un syndrome, un souffle tubaire, le souffle cavitare.

Le bilan a demandé ce qu'on voit. En premier, c'est toujours un cliché thoracique. Donc c'est une radiographie thoracique.

C'est logique. Est-ce que vous pouvez décrire la lésion? Est-ce que vous trouvez ce que vous voyez sur la radio? Est-ce que vous pouvez décrire la lésion? Est-ce que vous pouvez décrire la lésion? Je vous ai enseigné par une flèche. C'est celle-là.

C'est ça la lésion, toute celle-là. C'est une opacité basale gauche. Elle est gauche.

Elle est à gauche. C'est à gauche. Ce n'est pas à droite.

Mademoiselle Houdet, c'est à gauche. À droite, c'est ici. Donc c'est à gauche.

Donc c'est une opacité basale. C'est gauche, oui. Oui.

C'est un niveau, oui. Il y a un niveau. C'est ça, un niveau aérique.

Un niveau aérique, oui. Avec la paroi, elle est comment? La paroi, elle est... Elle est... La paroi, elle est... fine. Donc vous avez... opacité excavée avec un niveau et avec une paroi fine.

Donc avec cette image, quelle diagnostic vous évoquez? Les diagnostics à évoquer. Vous évoquez ce que vous voulez, on va discuter. Évoquez ce que vous voulez, on va discuter.

Les diagnostics à évoquer en premier. Les diagnostics que vous évoquez. Un abcès du poumon.

Abcès pulmonaire. Oui. Quoi d'autre? Un kystydatique.

Comment elle est, ce kystydatique pulmonaire? C'est un remanié compliqué. Le kystydatique pulmonaire, elle est comment? Parce que le kystydatique, ce n'est pas normal, ça. Normal, normalement, c'est une opacité claire.

Donc c'est un kystydatique remanié ou compliqué. Rompu ou fussuré. Surtout, c'est rompu.

Fussuré, on aura l'image en croissant. Mais ça, c'est un niveau hydroaérique. Fussuré, c'est en croissant.

C'est un kyst. Compliqué, kystydatique compliqué. Abcès, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous évoquez? Oui.

Vous avez l'abcès, vous avez le kyst. Quoi d'autre? Caverne tuberculeuse. Oui, une caverne tuberculeuse.

Une géante caverne tuberculeuse, c'est possible. Bien que c'est la colonisation au niveau du bas, un cancer bronchique excavé et un pyrothorax. Un pyrothorax localisé.

Un pyrothorax. Une pleurysie purulente qui est enquistée. Enquistée.

C'est probablement un syndrome cavitare. Quels sont les éléments radiologiques? Les éléments radiologiques en faveur de tel ou tel. On va voir les éléments radiologiques.

Les quatre signes radiologiques qui évoquent un abcès. Donc c'est une image hydroaérique. On a vu la paroi fine.

Il faut avoir les branches du drainage et surtout insister sur la variabilité du niveau. La variabilité du niveau. C'est-à-dire, lorsque vous faites une radio à telle date et vous faites dans une radio à une date autre, vous n'avez pas la même image.

Pourquoi? Une image d'abcès, cette image, si on l'a fait dans 3 jours, 4 jours, on n'a pas la même image. Pourquoi? C'est un signe qu'on doit chercher. Lorsqu'on fait des radios et ça change les images, c'est en faveur d'un abcès.

Parce qu'il y a un stade d'abcès à foyer fermé où l'image est constante. Il est à foyer ouvert. Il va expectorer le patient.

La taille va diminuer. Lorsqu'il y a une rétention des expectorations, on revient à la taille initiale. C'est ça, la variabilité du niveau sur plusieurs examens est très évocatrice d'un abcès.

Les diagnostics évoqués, vous avez un casse-tête le monnaie rempli, un abcès du poumon, un pectoral, un scaphère tuberculeuse et un cancer bronchique excavé. Donc, vous suspectez l'abcès pulmonaire. On est devant l'abcès pulmonaire.

L'abcès pulmonaire, son diagnostic, est-il clinique? Est-il radiologique? Est-il endoscopique? Comment est le diagnostic de l'abcès? La pleurésie pyrulente, c'est la ponction. La radio, c'est un élément d'orientation. L'abcès, le diagnostic, il est comment? Il est radiologique.

L'abcès, selon le diagnostic, il est radiologique. On fait le diagnostic de l'abcès devant une image cavitaire. Dans quel bilan vous allez demander, monsieur le patient? Quel bilan vous allez demander? Le bilan que vous allez demander, je suis passant avec cette image, avec ce niveau hydroaérique, et que vous suspectez un abcès pulmonaire.

Quel bilan vous allez demander? Il y a un bilan et un autre bilan. Il y a deux réponses. Un bilan, CRP9, numération formule VS.

C'est un bilan biologique. C'est un bilan d'orientation à la recherche d'un syndrome inflammatoire. En plus, on peut faire même la procacitonine.

La procacitonine. La microbiologie, oui, la microbiologie est très importante. La microbiologie, vous allez faire quoi avec la microbiologie? Les hémocultures, oui, c'est possible.

On peut faire l'examen acétobarque des explorations, on peut rechercher, on peut faire une bronchoscopie, la recherche des germes. C'est logique. Donc on va voir la réponse, les bilans qu'on doit faire.

Parce que vous avez ce malade avec cette image, donc vous avez fait un examen biologique d'orientation et un examen microbiologique pour rechercher le germe responsable. Donc, les examens, vous avez demandé la numération, donc on cherche une hyperleucocytose, la VS, la CRP, la procacitonine, la recherche d'un syndrome inflammatoire, sans oublier qu'on doit

chercher une part, parce que l'abcès pulmonaire ne se revient pas sur un sujet normal. Il se revient sur un terrain de débilité, c'est-à-dire un sujet immunodéprimé.

Donc il ne faut pas oublier de demander un ionogramme à la recherche d'un diabète qui peut favoriser le survenu d'abcès. Et l'examen microbiologique, comme celui de la pleurésie périllante, l'hémoculture, l'examen acétobarque des explorations, les prélèvements au cours de la fibroscopie, sans oublier les portes d'entrée. On va rechercher également, sans oublier de rechercher les BK, parce que c'est un diagnostic différentiel.

Donc, le message, c'est quoi ? Devant tout abcès pulmonaire ou une pleurésie périllante, il faut faire une endoscopie bronchique à la recherche de néoplasies. C'est un message que vous devez retenir pendant toute votre vie ou d'autres pratiques médicales, si vous êtes généraliste ou spécialiste. Donc tout abcès du poumon ou une supérotation pleura, c'est-à-dire une pleurésie périllante, vous devez faire une endoscopie bronchique, en dehors de chercher les germes, mais surtout à la recherche d'une néoplasie bronchique.

Nous avons dit que, parmi les abcès, il y a les abcès qui sont les abcès qui sont bactériens, agents banals, un aérobion écrasant. Il y a la tuberculose qu'on a éliminée, mais il y a un particulier de l'abcès amibien. Quelles sont les caractéristiques de l'abcès amibien ? Ça, c'est une question, ça tombe toujours, l'abcès amibien.

L'abcès amibien, il est souvent à droite ou à gauche ? L'abcès amibien, il est souvent à droite ou à gauche ? Il est à droite. Très bien. Il est à droite, souvent à droite.

Est-ce que c'est un abcès bactérien ? Est-ce que c'est un abcès bactérien ? Amicrobien. Donc, le prélèvement, il est un bactérien. C'est un abcès, on le fait, le prélèvement, on cherche des gens banals, des gens aérobies, anaérobies, des oxygrammes, les graines positives, négatives, c'est un abcès abactérien, amicrobien, souvent à droite.

Et le pu, l'aspect du pu, il est comment ? L'aspect est très caractéristique du pu. Brun chocolat, dans la vomique, brun chocolat, comme du chocolat. Est-ce qu'il répond aux antibiotiques ? Est-ce qu'il répond aux antibiotiques ? Est-ce qu'il répond à la amoxycilline ? Il ne répond pas à l'amoxycilline.

Il répond aux imidazolines. Il ne répond pas, donc c'est les abactériens, chocolat. Qu'est-ce qu'on doit chercher comme élément qui va nous orienter vers l'abcès amibien ? Il faut chercher une localisation de l'abcès.

Où ? Les antécédents, oui, de localisation de l'abcès au niveau du foie. Si on a un abcès du foie et un abcès au niveau du poumon, c'est probablement un abcès amibien. Et rechercher une amibiase intestinale.

Donc dans l'interrogatoire, il faut rechercher cette amibiase intestinale. C'est-à-dire un syndrome

des enterriques, des diarrhées, des saignements. Donc, on va voir.

Ça, c'est la réponse de la question que vous posez pour se souvenir de ce slide. Donc, l'abcès amibien, il est de siège basal droit. Il est de caractère amicrobien.

La coloration, il est brun chocolat. Dans ses antécédents, on va chercher une amibiase intestinale ou un abcès du foie. Le traitement des preuves, c'est les mytines.

Ce ne sont pas des antibiotiques. Le diagnostic, il est sérologique parce qu'on ne va pas trouver les germes au niveau du prélèvement bactériologique. Pour le traitement, comment vous traitez un abcès ? Comment vous allez traiter un abcès ? Comment vous allez traiter un abcès ? Un abcès du poumon.

Est-ce que vous allez hospitaliser le malade ou le traiter en ambulatoire ? L'abcès du poumon, vous le traitez en ambulatoire ou à l'hôpital ? L'abcès du poumon, est-ce que son traitement est à l'hôpital ou en ambulatoire ? C'est à l'hôpital. Il faut hospitaliser. Oui, le traitement de l'abcès, il faut le traiter à l'hôpital.

Ce n'est pas à la maison. Ce n'est pas en ambulatoire. Il faut le traiter à l'hôpital.

Quoi d'autre ? À l'hôpital. Il faut le traiter à l'hôpital. Antibiotiques, il ne peut pas avoir injectables au début.

La durée. La durée. Est-ce qu'il est court ? Comme l'apnéopathie, 7 à 10 jours, 1 à 2 semaines, vous prolongez.

Ce n'est pas 8 semaines. C'est entre 4 à 8 semaines. On ne va pas donner les chiffres.

On va vous donner... Non, ce n'est pas 6 mois. C'est autre chose. C'est autre chose.

Ce n'est pas ça. C'est entre 1 mois à 2 mois. Entre 1 mois à 2 mois.

Pour éviter ce l'abcès. La durée est prolongée. Ça ne dépasse pas 2 mois.

Ce n'est pas 6 mois. Durée prolongée. Entre 4 à 8 semaines.

Pour moi, c'est 4 à 8 semaines. On peut faire 4, 6, 8. Dans les questions, on ne va pas vous donner 4 ou 8 semaines. On va vous donner la durée du traitement.

Est-ce qu'il est court ou prolongé ? Évidemment, la durée du traitement est prolongée. Donc, hospitalisation, antibiotérapie, quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Il ne faut pas oublier la kinésithérapie respiratoire. Il faut reprendre le message.

Le message de la traitement, de l'abcès ou la supération. Ce que vous allez voir, c'est comme on a vu dans la pleurisie périlente. C'est l'hospitalisation, l'association d'antibiotérapie synergique par

voie parentérale.

Un traitement qui doit être précoce. Il va reposer ses prélèvements. On va traiter empiriquement, mais on doit recueillir les résultats pour adapter en fonction du germe et que la durée est prolongée, entre 4 à 8 semaines.

Sans oublier la kinésithérapie respiratoire. Sans oublier le traitement d'état. On a fait déjà le traitement d'un diabète.

On a fait une fibroscopie. Parfois, on va rechercher un corps étranger. Probablement, c'est un corps étranger.

On peut le retirer. Sans oublier, dans les cas des pleurises périlentes, il ne faut pas oublier de voir l'examen de la cavité buccale à la recherche de caries. Il faut traiter les caries.

Il faut rechercher des sites sinusites. Le traitement des foyers et des portes entrées est très important dans le cas des infections. Vous allez traiter comment vous allez surveiller votre patient.

Votre malade est hospitalisé. Vous êtes un bon médecin. Vous prenez la voie veineuse.

Vous transcrivez des associations. Vous lui donnez des traitements symptomatiques. Vous faites la kinésiothérapie respiratoire.

Vous avez équilibré cet art. Mais comment vous allez surveiller l'évolution ? La surveillance est basée sur trois éléments. Quels sont les éléments de surveillance ? Les éléments de surveillance, c'est quoi ? Les éléments pour surveiller ce patient.

Les éléments de surveillance. Toutes les pathologies X, c'est la clinique, c'est la biologie, et c'est la radiologie. Toute infection, qu'elle soit urinaire, cardiaque, je ne sais pas, abdominal, la clinique, la biologie et l'imagerie.

On commence par la clinique. Comment vous allez surveiller votre patient ? Sur quels critères cliniques ? Chaque clinique est importante. La clinique, c'est un élément important que vous cherchez.

Non, ce n'est pas la saturation, la fréquence. C'est l'infection. Vous cherchez quoi ? La fièvre et l'état général.

La fièvre et l'état général. La température et l'état général. Ce n'est pas tout.

La régression de la fièvre, parce que c'est de l'infection, il avait une fièvre à 39. Vous avez surveillé quoi ? Vous avez surveillé sa température et l'état général. Et quoi d'autre ? Ce n'est pas tout ce que vous avez cherché.

L'expectoration. Oui, bravo Imane, l'expectoration. Par quoi on va chercher ? Par quoi on fait quoi pour la surveillance des expectorations ? Par la courbe des expectorations.

C'est la courbe des expectorations. Donc la surveillance clinique, de manière générale, sur l'état général. Le plus important, c'est la fièvre, parce que c'est de l'infection.

C'est de la fièvre à 39. Pour avoir l'évolution de la fièvre, on va obtenir une apérixie, c'est-à-dire la disparition de la fièvre, et surtout par la courbe des expectorations. C'est-à-dire le volume d'expectorations chaque jour.

Lorsque ça s'est diminué, c'est une bonne évolution. Donc la surveillance clinique, elle est basée sur les signes généraux, sur la température, et sur la courbe des expectorations. La courbe des expectorations.

Donc, c'est la biologie, vous avez les bétons que vous avez demandé, la numération, l'AVS, et la CRP, et la radiologie, c'est la radiographie du thorax. Donc la surveillance, elle est clinique, elle est biologique, et elle est radiologique. On va voir s'il y a une conclusion.

Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? On a fait 3 cas. Une pleurésie exudative, tuberculeuse, chez un patient de 22 ans. À travers ça, on a dit que le diagnostic de confirmation d'une pleurésie, elle est par la ponction, et que la radiologie, c'est un élément d'orientation.

Et devant l'aspect des liquides, la première question, c'est répondre à la question, est-ce que c'est un transsuda ou est-ce qu'un exuda par la mesure du taux de protéines? Lorsqu'il est inférieur à 25 g, c'est un transsuda. Lorsqu'il est supérieur à 35 g, c'est un exuda. Entre les deux, on va s'aider par utiliser les critères de l'AIDS qui sont le LDH, le rapport LDH-pleurase-LDH-stérique et le rapport de protéines pleurases et de protéines stériques.

Lorsqu'on va répondre à la question, c'est un exuda, donc on va rechercher l'étiologie et par quel bilan. On va chercher l'imprélèvement pour rechercher les germes, rechercher les BK, et la cytologie. Lorsque ça ne se trouve pas, on va faire la ponction biopsie pleurale.

Il faut rappeler que la ponction pleurale se fait en pleine matité, en rasant le bord de la côte inférieure, en éliminant les contre-indications de la ponction pleurale. Pour différencier entre pleurésie transsida et exudative, la pleurésie transsida, c'est une pleurésie où la plèvre est normale. Dans le cas de la pleurésie transsida, il n'y a pas d'indication de la biopsie pleurale.

Dans le cas de la pleurésie exudative, il faut faire la ponction biopsie pleurale dans un bilan étiologique. On a fait comme exemple les étiologies les plus fréquentes des pleurésies exudatives. Vous avez la tuberculose, la tumeur, les cardiovasculaires et les collagenoses.

Le tableau typique qu'on a pris, c'est une pleurésie tuberculeuse et son traitement de la pleurésie

tuberculeuse est basé sur les antibacillaires, sur la kinésithérapeute respiratoire et les vacuations. Ce n'est pas le drainage, mais les vacuations. On parle du drainage dans le cas de la pleurésie purulente.

On parle du drainage dans le cas de la pleurésie purulente. On a parlé de la pleurésie purulente. Il faut savoir qu'il y a 3 stades de diffusion, de collection et d'enquêtement.

L'insuffisance cardiaque ne contreindique pas la ponction. La ponction est inutile. L'insuffisance cardiaque vous avez un malheur cardiaque.

Pourquoi vous êtes traumatisé avec une ponction alors que vous ne traitez pas du diurétique alors que le liquide va disparaître ? Ce n'est pas une contreindication. C'est l'étiologie. Elle est connue.

Donc, il ne faut pas ponctionner une insuffisance cardiaque. C'est-à-dire, lorsque tu adaptes ton traitement à la physique cardiaque, le liquide va disparaître parce que c'est un liquide transsédatif. Pourquoi vous allez le ponctionner à l'hôpital pour désigner l'expression.

Comment on dit ? L'expression. À l'hôpital, quoi ? À l'hôpital. C'est quoi l'hôpital ? C'est quoi votre question ? L'insuffisance cardiaque ne contreindique pas la ponction.

L'insuffisance cardiaque, c'est une étiologie. C'est un transsida. Lorsqu'on traite l'étiologie, dans le cas du transsida, il faut traiter l'étiologie.

Lorsqu'on traite l'insuffisance cardiaque, le liquide va disparaître. Pourquoi tu vas traumatiser un malade avec une ponction, avec le risque de faire des saignements, de l'infection. Ce n'est pas une contreindication.

L'insuffisance cardiaque, c'est une cause du transsida. Et lorsqu'on ne ponctionne pas, parce qu'il va évoluer favorablement sous le traitement diurétique. On n'a pas besoin de vous ponctionner.

On va adapter votre traitement, il va disparaître le liquide. Oui, quoi d'autre ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Là, c'est bien, parce que c'est compliqué dans les enterrées. Et dans les enterrées, le système porte va passer par le foie et va passer par le poumon.

Comme le cas du quixidatique. Le quixidatique, il est souvent à droite. Le quixidatique, le passage parasitaire, ça traverse avec le système porte.

Donc, on va trouver l'intestin, le foie, le premier barrage. Puis, on aura le poumon droit. Oui.

Est-ce que vous avez d'autres questions de clore ? Oui. Est-ce que vous avez des questions ? J'espère que c'était bien compris. Il n'y a pas beaucoup de questions.

Et pour le prochain, on va parler, le prochain... On va parler, on va faire des cas de la primo-

infection tuberculeuse, de la tuberculose pulmonaire commune et des formes graves de tuberculose. Donc, sur le prochain thème, ce sera sur la tuberculose pour vous avoir des prérequis après, pour faciliter l'apprentissage. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de terminer ? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis dans l'apprentissage ? Est-ce que vous avez des soucis dans le cours ? Des questions que vous voulez que je vous réponde ? D'une manière générale, les réponses, vos réponses étaient justes et je suis content de vos réponses.

De toute façon, je ne trouve pas qu'il y a de difficultés dans les choses. Donc, pour moi, pleurésie, la première question, caractériser une pleurésie excitative, caractériser une pleurésie transidative. La deuxième chose, quelles sont les étymologies d'une pleurésie excitative ? Quelles sont les pleurésies transidatives ? Puis après, on va faire les pleurésies périllantes.

Est-ce que c'est une urgence ? Est-ce que le traitement, est-ce que on doit faire une fibroscopie sur les caractéristiques de la pleurésie ? Et de la même manière, collapser. Et de la même manière, collapser ambien. Je crois que ces questions vont se poser dans ces thèmes.

De toute façon, ces thèmes. J'espère que vous n'avez pas trop de soucis dans ce domaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.

Je serai pour la prochaine séance. On fera un récapitulatif de ce qu'on a fait. Donc, j'espère que c'est simple.

J'espère que le message a été bien transmis. Je vous souhaite bonne chance et une bonne réussite. Inchallah.